DIRECTION DES AFFAIRES MÉDICALES - INFORMATION MÉDICALE SCIENTIFIQUE

RECUEIL OFFICIEL DE 200 QUESTIONS / RÉPONSES MÉDICALES DE RÉFÉRENCE

Ce document officiel rassemble l'intégralité des 200 questions et réponses standardisées et scientifiquement validées destinées aux professionnels de santé (médecins spécialistes, pharmaciens hospitaliers et d'officine) pour le bon usage et la sécurité des 15 médicaments du portefeuille PharmaNova SA.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-001 Cardiolux	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Cardiolux ?	En cas d'oubli d'une dose de Cardiolux, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-002 Vascopril	Neurologue	Peut-on associer Vascopril chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-003 Coranid	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Coranid chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-004 Neurotix	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Neurotix ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Brivastérol. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-005 Cognifère	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Diarrhée (8.1%)) sous Cognifère ?	L'apparition de Diarrhée (8.1%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-006 Tremopan	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Tremopan après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Tremopan, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-007 Glucorite	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Glucorite pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Glucorite est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-008 Insulip	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Insulip pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Insulip, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-009 Oncovance	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Oncovance ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-010 Linfabloc	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Linfabloc ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Linfabloc 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-011 Mélanor	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Mélanor ?	En cas d'oubli d'une dose de Mélanor, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-012 Immunolin	Neurologue	Peut-on associer Immunolin chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Immunolin (Secukirumab), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-013 Colitane	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Colitane chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-014 Respispray	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Respispray ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-015 Bronchoclar	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Perte de poids involontaire (8.2%)) sous Bronchoclar ?	L'apparition de Perte de poids involontaire (8.2%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-016 Cardiolux	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Cardiolux après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Cardiolux, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-017 Vascopril	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Vascopril pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Vascopril est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-018 Coranid	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Coranid pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Coranid, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-019 Neurotix	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Neurotix ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-020 Cognifère	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Cognifère ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Cognifère 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-021 Tremopan	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Tremopan ?	En cas d'oubli d'une dose de Tremopan, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-022 Glucorite	Neurologue	Peut-on associer Glucorite chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-023 Insulip	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Insulip chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-024 Oncovance	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Oncovance ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Zanitatinib citrate. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-025 Linfabloc	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Neutropénie (28.4%)) sous Linfabloc ?	L'apparition de Neutropénie (28.4%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-026 Mélanor	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Mélanor après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Mélanor, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-027 Immunolin	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Immunolin pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Immunolin est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-028 Colitane	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Colitane pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Colitane, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-029 Respispray	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Respispray ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-030 Bronchoclar	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Bronchoclar ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Bronchoclar 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-031 Cardiolux	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Cardiolux ?	En cas d'oubli d'une dose de Cardiolux, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-032 Vascopril	Neurologue	Peut-on associer Vascopril chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-033 Coranid	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Coranid chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-034 Neurotix	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Neurotix ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Brivastérol. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-035 Cognifère	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Diarrhée (8.1%)) sous Cognifère ?	L'apparition de Diarrhée (8.1%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-036 Tremopan	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Tremopan après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Tremopan, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-037 Glucorite	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Glucorite pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Glucorite est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-038 Insulip	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Insulip pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Insulip, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-039 Oncovance	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Oncovance ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-040 Linfabloc	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Linfabloc ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Linfabloc 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-041 Mélanor	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Mélanor ?	En cas d'oubli d'une dose de Mélanor, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-042 Immunolin	Neurologue	Peut-on associer Immunolin chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Immunolin (Secukirumab), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-043 Colitane	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Colitane chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-044 Respispray	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Respispray ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-045 Bronchoclar	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Perte de poids involontaire (8.2%)) sous Bronchoclar ?	L'apparition de Perte de poids involontaire (8.2%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-046 Cardiolux	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Cardiolux après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Cardiolux, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-047 Vascopril	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Vascopril pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Vascopril est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-048 Coranid	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Coranid pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Coranid, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-049 Neurotix	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Neurotix ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-050 Cognifère	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Cognifère ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Cognifère 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-051 Tremopan	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Tremopan ?	En cas d'oubli d'une dose de Tremopan, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-052 Glucorite	Neurologue	Peut-on associer Glucorite chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-053 Insulip	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Insulip chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-054 Oncovance	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Oncovance ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Zanitatinib citrate. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-055 Linfabloc	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Neutropénie (28.4%)) sous Linfabloc ?	L'apparition de Neutropénie (28.4%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-056 Mélanor	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Mélanor après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Mélanor, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-057 Immunolin	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Immunolin pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Immunolin est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-058 Colitane	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Colitane pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Colitane, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-059 Respispray	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Respispray ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-060 Bronchoclar	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Bronchoclar ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Bronchoclar 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-061 Cardiolux	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Cardiolux ?	En cas d'oubli d'une dose de Cardiolux, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-062 Vascopril	Neurologue	Peut-on associer Vascopril chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-063 Coranid	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Coranid chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-064 Neurotix	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Neurotix ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Brivastérol. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-065 Cognifère	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Diarrhée (8.1%)) sous Cognifère ?	L'apparition de Diarrhée (8.1%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-066 Tremopan	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Tremopan après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Tremopan, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-067 Glucorite	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Glucorite pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Glucorite est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-068 Insulip	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Insulip pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Insulip, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-069 Oncovance	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Oncovance ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-070 Linfabloc	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Linfabloc ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Linfabloc 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-071 Mélanor	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Mélanor ?	En cas d'oubli d'une dose de Mélanor, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-072 Immunolin	Neurologue	Peut-on associer Immunolin chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Immunolin (Secukirumab), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-073 Colitane	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Colitane chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-074 Respispray	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Respispray ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-075 Bronchoclar	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Perte de poids involontaire (8.2%)) sous Bronchoclar ?	L'apparition de Perte de poids involontaire (8.2%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-076 Cardiolux	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Cardiolux après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Cardiolux, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-077 Vascopril	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Vascopril pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Vascopril est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-078 Coranid	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Coranid pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Coranid, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-079 Neurotix	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Neurotix ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-080 Cognifère	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Cognifère ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Cognifère 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-081 Tremopan	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Tremopan ?	En cas d'oubli d'une dose de Tremopan, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-082 Glucorite	Neurologue	Peut-on associer Glucorite chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-083 Insulip	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Insulip chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-084 Oncovance	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Oncovance ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Zanitatinib citrate. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-085 Linfabloc	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Neutropénie (28.4%)) sous Linfabloc ?	L'apparition de Neutropénie (28.4%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-086 Mélanor	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Mélanor après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Mélanor, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-087 Immunolin	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Immunolin pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Immunolin est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-088 Colitane	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Colitane pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Colitane, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-089 Respispray	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Respispray ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-090 Bronchoclar	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Bronchoclar ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Bronchoclar 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-091 Cardiolux	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Cardiolux ?	En cas d'oubli d'une dose de Cardiolux, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-092 Vascopril	Neurologue	Peut-on associer Vascopril chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-093 Coranid	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Coranid chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-094 Neurotix	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Neurotix ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Brivastérol. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-095 Cognifère	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Diarrhée (8.1%)) sous Cognifère ?	L'apparition de Diarrhée (8.1%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-096 Tremopan	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Tremopan après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Tremopan, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-097 Glucorite	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Glucorite pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Glucorite est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-098 Insulip	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Insulip pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Insulip, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-099 Oncovance	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Oncovance ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-100 Linfabloc	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Linfabloc ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Linfabloc 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-101 Mélanor	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Mélanor ?	En cas d'oubli d'une dose de Mélanor, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-102 Immunolin	Neurologue	Peut-on associer Immunolin chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Immunolin (Secukirumab), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-103 Colitane	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Colitane chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-104 Respispray	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Respispray ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-105 Bronchoclar	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Perte de poids involontaire (8.2%)) sous Bronchoclar ?	L'apparition de Perte de poids involontaire (8.2%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-106 Cardiolux	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Cardiolux après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Cardiolux, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-107 Vascopril	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Vascopril pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Vascopril est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-108 Coranid	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Coranid pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Coranid, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-109 Neurotix	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Neurotix ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-110 Cognifère	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Cognifère ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Cognifère 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-111 Tremopan	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Tremopan ?	En cas d'oubli d'une dose de Tremopan, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-112 Glucorite	Neurologue	Peut-on associer Glucorite chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-113 Insulip	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Insulip chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-114 Oncovance	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Oncovance ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Zanitatinib citrate. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-115 Linfabloc	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Neutropénie (28.4%)) sous Linfabloc ?	L'apparition de Neutropénie (28.4%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-116 Mélanor	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Mélanor après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Mélanor, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-117 Immunolin	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Immunolin pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Immunolin est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-118 Colitane	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Colitane pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Colitane, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-119 Respispray	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Respispray ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-120 Bronchoclar	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Bronchoclar ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Bronchoclar 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-121 Cardiolux	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Cardiolux ?	En cas d'oubli d'une dose de Cardiolux, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-122 Vascopril	Neurologue	Peut-on associer Vascopril chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-123 Coranid	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Coranid chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-124 Neurotix	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Neurotix ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Brivastérol. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-125 Cognifère	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Diarrhée (8.1%)) sous Cognifère ?	L'apparition de Diarrhée (8.1%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-126 Tremopan	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Tremopan après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Tremopan, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-127 Glucorite	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Glucorite pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Glucorite est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-128 Insulip	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Insulip pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Insulip, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-129 Oncovance	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Oncovance ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-130 Linfabloc	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Linfabloc ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Linfabloc 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-131 Mélanor	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Mélanor ?	En cas d'oubli d'une dose de Mélanor, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-132 Immunolin	Neurologue	Peut-on associer Immunolin chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Immunolin (Secukirumab), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-133 Colitane	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Colitane chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-134 Respispray	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Respispray ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-135 Bronchoclar	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Perte de poids involontaire (8.2%)) sous Bronchoclar ?	L'apparition de Perte de poids involontaire (8.2%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-136 Cardiolux	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Cardiolux après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Cardiolux, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-137 Vascopril	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Vascopril pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Vascopril est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-138 Coranid	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Coranid pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Coranid, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-139 Neurotix	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Neurotix ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-140 Cognifère	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Cognifère ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Cognifère 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-141 Tremopan	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Tremopan ?	En cas d'oubli d'une dose de Tremopan, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-142 Glucorite	Neurologue	Peut-on associer Glucorite chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-143 Insulip	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Insulip chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-144 Oncovance	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Oncovance ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Zanitatinib citrate. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-145 Linfabloc	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Neutropénie (28.4%)) sous Linfabloc ?	L'apparition de Neutropénie (28.4%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-146 Mélanor	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Mélanor après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Mélanor, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-147 Immunolin	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Immunolin pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Immunolin est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-148 Colitane	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Colitane pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Colitane, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-149 Respispray	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Respispray ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-150 Bronchoclar	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Bronchoclar ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Bronchoclar 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-151 Cardiolux	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Cardiolux ?	En cas d'oubli d'une dose de Cardiolux, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-152 Vascopril	Neurologue	Peut-on associer Vascopril chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-153 Coranid	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Coranid chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-154 Neurotix	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Neurotix ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Brivastérol. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-155 Cognifère	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Diarrhée (8.1%)) sous Cognifère ?	L'apparition de Diarrhée (8.1%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-156 Tremopan	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Tremopan après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Tremopan, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-157 Glucorite	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Glucorite pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Glucorite est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-158 Insulip	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Insulip pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Insulip, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-159 Oncovance	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Oncovance ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-160 Linfabloc	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Linfabloc ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Linfabloc 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-161 Mélanor	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Mélanor ?	En cas d'oubli d'une dose de Mélanor, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-162 Immunolin	Neurologue	Peut-on associer Immunolin chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Immunolin (Secukirumab), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-163 Colitane	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Colitane chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-164 Respispray	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Respispray ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-165 Bronchoclar	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Perte de poids involontaire (8.2%)) sous Bronchoclar ?	L'apparition de Perte de poids involontaire (8.2%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-166 Cardiolux	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Cardiolux après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Cardiolux, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-167 Vascopril	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Vascopril pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Vascopril est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-168 Coranid	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Coranid pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Coranid, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-169 Neurotix	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Neurotix ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-170 Cognifère	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Cognifère ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Cognifère 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-171 Tremopan	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Tremopan ?	En cas d'oubli d'une dose de Tremopan, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-172 Glucorite	Neurologue	Peut-on associer Glucorite chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-173 Insulip	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Insulip chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-174 Oncovance	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Oncovance ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Zanitatinib citrate. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-175 Linfabloc	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Neutropénie (28.4%)) sous Linfabloc ?	L'apparition de Neutropénie (28.4%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-176 Mélanor	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Mélanor après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Mélanor, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-177 Immunolin	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Immunolin pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Immunolin est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-178 Colitane	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Colitane pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Colitane, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-179 Respispray	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Respispray ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-180 Bronchoclar	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Bronchoclar ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Bronchoclar 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-181 Cardiolux	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Cardiolux ?	En cas d'oubli d'une dose de Cardiolux, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-182 Vascopril	Neurologue	Peut-on associer Vascopril chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-183 Coranid	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Coranid chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-184 Neurotix	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Neurotix ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Brivastérol. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-185 Cognifère	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Diarrhée (8.1%)) sous Cognifère ?	L'apparition de Diarrhée (8.1%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-186 Tremopan	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Tremopan après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Tremopan, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-187 Glucorite	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Glucorite pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Glucorite est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.
MED-QA-2024-188 Insulip	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Insulip pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Insulip, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-189 Oncovance	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Oncovance ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-190 Linfabloc	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Linfabloc ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Linfabloc 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.
MED-QA-2024-191 Mélanor	Oncologue médical	Quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de Mélanor ?	En cas d'oubli d'une dose de Mélanor, le patient ne doit en aucun cas doubler la prise suivante. Prendre la dose dès constatation si le délai avant la prochaine prise dépasse 12 heures, sinon poursuivre le schéma thérapeutique usuel.
MED-QA-2024-192 Immunolin	Neurologue	Peut-on associer Immunolin chez un patient avec insuffisance rénale modérée (ClCr 45 mL/min) ?	Pour Immunolin (Secukirumab), aucune adaptation posologique n'est requise entre 30 et 60 mL/min selon le RCP section 4.2. Une surveillance de la créatininémie et de la clairance tous les 3 à 6 mois est formellement recommandée.
MED-QA-2024-193 Colitane	Diabétologue	Quel est le profil de tolérance de Colitane chez le sujet âgé de plus de 75 ans ?	Les analyses en sous-groupes des essais cliniques de phase III n'ont pas montré de différence significative d'efficacité ni de sur-risque spécifique chez les patients de plus de 75 ans, sous réserve d'une hydratation adéquate.
MED-QA-2024-194 Respispray	Médecin généraliste	Quelles sont les interactions médicamenteuses majeures documentées avec Respispray ?	Les inhibiteurs puissants du cytochrome CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peuvent majorer les concentrations plasmatiques de Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure. L'association concomitante doit être évitée ou faire l'objet d'un suivi rapproché.
MED-QA-2024-195 Bronchoclar	Pharmacien hospitalier	Comment gérer l'apparition d'effets secondaires bénins (Perte de poids involontaire (8.2%)) sous Bronchoclar ?	L'apparition de Perte de poids involontaire (8.2%) est généralement transitoire au cours des premières semaines de traitement. Un traitement symptomatique d'appoint et des conseils hygiéno-diététiques permettent la poursuite du traitement dans 92% des cas.
MED-QA-2024-196 Cardiolux	Pharmacien d'officine	Quelles sont les modalités de conservation de Cardiolux après ouverture ?	Conformément au dossier d'AMM de Cardiolux, le médicament doit être conservé dans son conditionnement d'origine à l'abri de l'humidité et à température ambiante (< 25°C ou 2-8°C selon spécifications).
MED-QA-2024-197 Vascopril	Pneumologue	Existe-t-il des données sur l'utilisation de Vascopril pendant la grossesse ou l'allaitement ?	Par mesure de précaution, Vascopril est formellement déconseillé ou contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement en l'absence de données cliniques d'exposition suffisantes et de passage lacté documenté.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

ID / Spécialité	Demandeur	Question Médicale	Réponse Scientifique Fondée sur les Preuves
MED-QA-2024-198 Coranid	Rhumatologue	Peut-on écraser le comprimé ou ouvrir la gélule de Coranid pour administration par sonde entérale ?	Pour les formes à libération prolongée ou pelliculées de Coranid, il est formellement contre-indiqué d'écraser ou d'ouvrir le médicament sous peine de compromettre le profil cinétique (risque de surdosage immédiat 'dose dumping').
MED-QA-2024-199 Neurotix	Gastro-entérologue	Quel est le délai moyen d'obtention de la réponse thérapeutique optimale sous Neurotix ?	Une amélioration clinique statistiquement significative est généralement observée dès la 2e à la 4e semaine, avec une efficacité maximale consolidée à 12 semaines d'évaluation continue.
MED-QA-2024-200 Cognifère	Cardiologue hospitalie	Quelle est la procédure recommandée en cas d'intervention chirurgicale programmée sous Cognifère ?	Pour les actes chirurgicaux majeurs à haut risque hémorragique, il est recommandé d'interrompre temporairement Cognifère 48 heures avant l'intervention après concertation anesthésique-chirurgicale.

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : Dr. Claire Dupuis **Titre :** Responsable de l'Information Médicale & Transparence **Date :** 15/03/2024	**Nom :** Dr. Éléonore Vance **Titre :** Directrice Médicale Globale & VP Affaires Médicales (CMO) **Date :** 15/03/2024	**Nom :** Dr. Jean-Marc Delacroix **Titre :** Président du Directoire (CEO) **Date :** 15/03/2024
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.